

ΝΥΓΜΟΣ ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΟΥ

Γενικά: Τα υμενόπτερα (*Hymenoptera*) είναι αρθρόποδα που ανήκουν στην τάξη των εντόμων και περιλαμβάνει πάνω από 150.000 διαφορετικά είδη ιπτάμενων και μη εντόμων.

Τοξικολογικό ενδιαφέρον, για τη χώρα μας, παρουσιάζουν δύο κατηγορίες: τα είδη Vespids [σφήκα (*Vespula vulgaris*), μεγάλη σφήκα, σκούρκος/σερσέγκι (*Vespa orientalis*)] και τα είδη Rapids [μέλισσα (*Apis mellifera*) και βομβίνος/μπάμπουρας (*Bombus agrorum*)].

Η συσκευή κεντρίσματος των υμενόπττερων βρίσκεται στο οπίσθιο μέρος της κοιλιακής χώρας του θηλυκού εντόμου και αποτελείται από έναν σάκο που περιέχει το δηλητήριο και από ένα τριχωτό κεντρί. Το κεντρί της μέλισσας φέρει πολλαπλά τριχίδια με κατεύθυνση προς τα πίσω που αγκιστρώνονται στο δέρμα του θύματος, ενώ της σφήκας έχει λίγα. Η οικογένεια των Apidae (μέλισσες και βομβίνοι, μεταξύ άλλων) συνήθως δεν είναι επιθετική και τσιμπούν μόνον όταν απειλούνται ή προκαλούνται. Αντιθέτως, η οικογένεια Vespidae (σφήκες, κίτρινες σφήκες) είναι πιο επιθετική από τους συγγενείς τους Apidae, ενώ δεν έχει αγκαθωτό κεντρί και ως εκ τούτου, μπορεί να τσιμπήσει πολλές φορές ένα θύμα.

Το δηλητήριο των εντόμων αποτελείται από διάφορα μίγματα πολυπεπτιδίων, ενζύμων και άλλων ουσιών, όπως ισταμίνης, σεροτονίνης, φωσφολιπάσης A₂, υαλουρονιδάσης, κ.ά.

Αυξημένο κίνδυνο νυγμού διατρέχουν, κυρίως, οι ενήλικοι άρρενες και τα εκτιθέμενα επαγγελματικά άτομα (μελισσοκόμοι, ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, χειριστές μηχανημάτων), σπανιότερα δε τα παιδιά στο πλαίσιο του παιχνιδιού (π.χ. καταστρέφοντας μια σφηκοφωλιά).

Τα περισσότερα τσιμπήματα συμβαίνουν κατά το τέλος του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου. Οι ενήλικες παρουσιάζουν βαρύτερες αλλεργικές αντιδράσεις από ό,τι τα παιδιά. Η συχνότητα των αλλεργικών αντιδράσεων από νυγμούς υμενόπττερων στον γενικό πληθυσμό κυμαίνεται στο 1-4%. Τα άτομα με ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης σε νυγμό εντόμου κινδυνεύουν μετά από κάθε νέο τσίμπημα σε ποσοστό 35-60%.

Κλινική εικόνα: Η αντίδραση του ανθρώπου στο δηλητήριο των εντόμων ποικίλλει. Κυμαίνεται από μια απλή τοπική εκδήλωση στο σημείο του νυγμού και πέριξ αυτού, έως τη βαριά (ενίοτε απειλητική για τη ζωή) αναφυλακτική αντίδραση (βλ. σελ. 292). Η τελευταία αναπτύσσεται στα ευαίσθητα άτομα απόρροια της αυξημένης παραγωγής IgE αντισωμάτων.

Τα τοπικά συμπτώματα ή εκδηλώσεις από τους νυγμούς υμενόπττερων διαρκούν λίγες ώρες (2-48 ώρες), είναι αυτοπεριοριζόμενα και περιλαμβάνουν συνήθως τοπικό κνησμό, ερύθημα, οίδημα, σκληρία, άλγος και αίσθημα καύσου. Οι ανατομικές περιοχές με χαλαρό ιστό (π.χ. χείλη, βλέφαρα, γεννητικά όργανα) παρουσιάζουν ενίοτε εντονότερο οίδημα, ενώ αρκετά συχνά, στο σημείο του νυγμού μπορεί να σχηματιστεί στείρα διαυγής πομφόλυγα.

Επί πολλαπλών νυγμών, παρουσιάζονται τοξικά φαινόμενα με γενικευμένο οίδημα στη νυχθείσα περιοχή, υπνηλία, κακουχία, πυρετό, λιποθυμία και σπασμούς. Άλλοτε, οι τοπικές αντιδράσεις μπορεί να είναι μεγαλύτερες, πιο επώδυνες και να διαρκούν περισσότερο. Αυτές εμφανίζονται σπανιότερα (N < 10% των νυγμών) και ονομάζονται μεγάλες τοπικές αντιδράσεις (*Large Local Reactions - LLR*), οι οποίες απαιτούν άμεσα ιατρική παρέμβαση και πιθανώς συστηματικότερη και πολυήμερη θεραπεία (υγρά, ινóτροπα, αντιβιοτικά, κ.ά.).

Οι αναφυλακτικές εκδηλώσεις συμβαίνουν εντός ολίγων λεπτών έως ολίγων ωρών και περιλαμβάνουν κνίδωση, ναυτία, εμέτους, ανησυχία, βρογχόσπασμο, υπόταση και αίσθημα βάρους στο θώρακα. Αυτές οι αντιδράσεις, όπως και άλλες αναφυλακτικές αντιδράσεις σε αλλεργιογόνα, συμβαίνουν μέσω της συστηματικής απελευθέρωσης της ισταμίνης με τη μεσολάβηση IgE. Τα μαστοκύτταρα και η ενεργοποίηση των βασεόφιλων οδηγούν τελικά σε συστηματική αγγειοδιαστολή, γενικευμένο αγγειοοίδημα, βρογχόσπασμο με συριγμό, βράγχος φωνής, σοβαρή υπόταση (MAP < 60-65 mmHg) που οδηγεί σε shock και θάνατο.

Σπανίως δε, μετά από 7-15 ημέρες, μπορεί να εκδηλωθούν συμπτώματα **ορονοσίας**, με νεφρική βλάβη, θρομβοπενία, ηπατίτιδα, λεμφαδενίτιδα, νευρολογικές εκδηλώσεις, κ.ά.

Διαφορική διάγνωση: Η Δ/Δ περιλαμβάνει την αντίδραση υπερευαισθησίας από άλλα έντομα, τη θυλακίτιδα, την κυτταρίτιδα, το δερματικό απόστημα, το αγγειοοίδημα, κ.ά.



Θεραπευτική παρέμβαση

1. Είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί το υπεύθυνο για το νυγμό έντομο, προκειμένου να γίνει η σωστή αντιμετώπιση. Εάν το τσίμπημα έχει προκληθεί από μέλισσα θα πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως το κεντρί που πιθανώς έχει παραμείνει στο δέρμα, με μια πιστωτική κάρτα, με βελόνα ή προσεκτικά με λαβίδα, χωρίς σύνθλιψη στο σημείο του νυγμού.
2. Σε ελαφρές περιπτώσεις συνιστάται απλώς, τοπικός καθαρισμός και πλύση, τοποθέτηση ψυχρών επιθεμάτων και πιθανώς αντισταμινικού gel, spray αμμονίας ή κορτιζονούχων αλοιφών προς ανακούφιση των συμπτωμάτων και ακινησία του πάσχοντος μέλους.
3. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (*BP, HR, RR, SpO₂, T°C*). Στους ασθενείς με συννοσηρότητα ίσως χρειαστεί και διενέργεια ΗΚΓ. Επίσης, σε ασθενείς με γενικευμένο εξάνθημα ή εκτεταμένη ιστική βλάβη πιθανώς να χρειαστεί και εργαστηριακός έλεγχος (*γενική αίματος, Glu, CRP, κ.ά.*) και περαιτέρω διερεύνηση και κλινική αξιολόγηση.
4. Εκτός από την επισκόπηση κι εξέταση του ασθενούς στο σημείο του νυγμού, αλλά και την επισκόπηση ολοκλήρου του σώματος για εξάνθημα ή άλλες βλάβες, ελέγχουμε τα παρίσθημα για οίδημα σταφυλής και ακροαζόμαστε το θώρακα για ύπαρξη συριγμού.
5. Σε έντονη, τοπική, δερματική αντίδραση χορηγούμε συστηματικώς αντιισταμινικά, ήτοι: 1 amp. Διμεθινδένη (*Fenistil*) σε 100 ml NaCl 0,9% (στάγδην - iv), εντός 15-20 λεπτών. Εφόσον δεν έχει επιτευχθεί φλεβική πρόσβαση: Χλωρφαιναμίνη (*Istamex*, tabl. 4 mg) ή Δεσλοραταδίνη (*Aerius*, tabl. 5 mg) ή Λεβοσετιριζίνη (*Xozal/Contrahist*, tabl. 5 mg) ή τέλος Βιλαστίνη (*Bilaz/Bilargen*, tabl. 20 mg).
6. Χορηγούμε, αναλόγως ηλικίας ή σωματικού βάρους, είτε Μεθυλπρεδνιζολόνη, δηλαδή 1 amp. *Lyo-Drol* (40 mg, 125 mg ή 500 mg) ή για άμεση δράση Υδροκορτιζόνη, δηλαδή 1 amp. *Lyo-Cortin* (100 mg, 250 mg ή 500 mg), ενδομυϊκώς (im) ή βραδέως iv-bolus, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το κλινικό ιστορικό του ασθενούς (π.χ. *AY, ΣΝ, ΣΔ, κ.ά.*).
Σε περίπτωση βρογχόσπασμου, τα κορτικοστεροειδή κρίνονται απολύτως αναγκαία, καθώς επίσης και για το γεγονός ότι περίπου στο 20-30% των περιπτώσεων, η αλλεργική αντίδραση μετά από νυγμό – κυρίως σε ευαισθητοποιημένα θύματα – είναι διφασική, με τη 2^η φάση να εμφανίζεται μετά από 1-8 ώρες και ενίοτε με μεγαλύτερη βαρύτητα!
7. Χορηγούνται επίσης 1-2 amp. Σιμετιδίνη (*Tagamet 200 mg*), εντός 100 ml NaCl 0,9%, ή 1 tab. Ρανιτιδίνη (*Zurfix 150 mg*) (po), για κάλυψη και των H₂ ισταμινικών υποδοχέων. Έχειδειχθεί ότι η χρήση των H₂ αναστολέων της ισταμίνης μειώνει σαφώς την έκταση των δερματικών βλαβών και του εξανθήματος. Οι PPIs (π.χ. *Losec, Nexium*) δεν έχουν θέση στην αντιμετώπιση των αντιδράσεων υπερευαισθησίας από νυγμούς εντόμων.
8. Σε περιπτώσεις εκτεταμένης ιστικής βλάβης περίξ του σημείου νυγμού, με συνοδό άλγος οίδημα, σκληρία κι αίσθημα καύσου ή με σημεία ευαισθησίας και μυικών δεσμιδώσεων χορηγούνται 1-2 amp. Calcium Gluconate 10%, εντός ορού 250 ml D₅W ή NaCl 0,9%.
9. Στην περίπτωση όπου στο σημείο του νυγμού, μετά το πέρας 24-48 ωρών, εμφανίζονται σημεία φλεγμονώδους εξεργασίας (*οίδημα, σκληρία, ερυθρότητα ή αιμορραγική βλάβη*) τότε μαζί με την αντιαλλεργική αγωγή πρέπει να χορηγείται και αντιβιοτική θεραπεία για διάστημα 5-7 ημέρων και να γίνεται κλινική επανεκτίμηση της βλάβης σε 48 ώρες.
Η αντιβιοτική αγωγή, για επιμολυσμένο τραύμα, μπορεί να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
 - Amoxi/Clav: (*Augmentin/Fugentin*) 1 gr, 1x2 ή 1x3 [po], ή
 - Ciprofloxacin: (*Ciproxin/Ladinin*) 500 mg, 1x2 [po], ή
 - Doxycycline: (*Vibramycin*) 100 mg, 1x2 [po] (*όχι σε παιδιά & εγκύους*), ή/και
 - Metronidazole: (*Flagyl/Flagymet*) 500 mg, 1x3 [po].
10. Ασθενείς με έντονη τοπική ή φλεγμονώδη αντίδραση, ιστορικό σοβαρής αλλεργίας ή με σημεία και συμπτώματα γενικευμένης αλλεργικής αντίδρασης (*βλ. εδάφιο: «αλλεργικές αντιδράσεις - αναφυλακτικό shock»*), πρέπει – αφού αντιμετωπισθούν καταλλήλως – να παρακολουθούνται για λίγες ώρες στη MBN του ΚΥ ή να διακομιστούν τάχιστα στο νοσοκομείο, υπό monitoring και να νοσηλευτούν εκεί, τουλάχιστον, για 24-48 ώρες.